

Doenças Infecciosas na Gestação – Avançado

Vamos falar sobre um tema que aparece com menos frequência nas provas, mas quando aparece, costuma derrubar muitos candidatos: a infecção por parvovírus B19 durante a gestação. Esse é daqueles assuntos que exigem conhecimento aprofundado, especialmente sobre as complicações fetais e o manejo obstétrico adequado.

Imagine a seguinte situação clínica: você está realizando o pré-natal de uma gestante na UBS com 20 semanas de idade gestacional. Ela relata que há uma semana apresentou um quadro de **artralgia, exantema, cefaleia e mialgia**, mas os sintomas regrediram espontaneamente. Como médico, você pensa em alguns diagnósticos diferenciais e solicita exames. O **NS1 para dengue** vem não reagente, os **anticorpos IgM e IgG para dengue** também vêm não reagentes. Você descarta dengue. O **CMV** (citomegalovírus) também retorna com IgM e IgG não reagentes. Mas aí vem o resultado crucial: **IgM e IgG para parvovírus B19 reagentes**. Diante desses achados, qual seria o seguimento mais adequado?

Essa é uma pergunta que exige raciocínio clínico refinado. Vamos juntos desvendar essa questão ao longo da aula de hoje. Antes de prosseguir, vale analisar outra questão que caiu em prova recente: uma gestante com 28 semanas tem diagnóstico de infecção por parvovírus B19. A melhor maneira de avaliar a principal complicação fetal nesse caso é qual? Guarde essa pergunta, porque ao final da aula você terá a resposta clara.

Entendendo o Agente Etiológico

O agente etiológico da parvovirose na gestação é o **parvovírus B19**, um vírus DNA que tem uma característica muito importante: ele possui **tropismo pelas células do**

sistema hematopoético. Quando você lê isso, já deve começar a imaginar quais são as possíveis complicações. Se o vírus ataca as células formadoras do sangue, naturalmente teremos problemas relacionados à produção de células sanguíneas.

Além de ser uma infecção viral que pode gerar **exantema infeccioso**, especialmente na infância (embora qualquer indivíduo acometido possa apresentar exantema), o parvovírus B19 infecta especificamente as células do sistema hematopoético. Por conta disso, pode gerar **aplasia medular** em pacientes com anemia hemolítica crônica, pode causar **falência crônica de medula óssea** em pacientes imunodeficientes, e até mesmo provocar **encefalite, meningite** e **vasculites** por reações inflamatórias associadas à resposta imune ao vírus.

Grupos de Risco e Transmissão

Identificou padrões de questões e preparou esclarecimentos críticos.

O professor menciona que as gestantes são mais suscetíveis e que há maior risco de contato entre mulheres que trabalham com crianças. Vou deixar isso claro e adicionar um comentário crítico sobre o padrão de questões.

As gestantes são naturalmente mais suscetíveis à infecção, e o maior risco de contato ocorre entre mulheres que trabalham com crianças, como **professoras** e **donas de casa com filhos em idade escolar**. Aqui vai um **comentário crítico importante**: geralmente quando a questão traz um caso clínico de parvovírus B19, ela apresenta aquela história clássica da professora de creche que começou a evoluir com exantema e artralgia, e depois desenvolve alterações fetais. Fique atento a esse padrão de enunciado.

A **transmissão** é via respiratória, através de gotículas de saliva. O período de maior risco fetal é quando a infecção materna ocorre no **primeiro e no segundo trimestre** da gestação.

Complicações Fetais: O Coração da Questão

Aqui está o ponto crucial que as provas adoram cobrar. Quais são as alterações fetais causadas pelo parvovírus B19? Primeiramente, pode ocorrer **aborto espontâneo** e **óbito intrauterino**. Mas a complicação mais comum e geralmente mais dramática, que demanda manejo obstétrico intenso, é a **anemia fetal**.

Vamos entender a fisiopatologia: o parvovírus B19 gera anemia hemolítica porque destrói as células precursoras dos glóbulos vermelhos. O feto perde hemácias, desenvolve anemia grave, e essa anemia pode evoluir para complicações ainda mais sérias. Mas aqui vem uma dúvida prática: como avaliamos se o feto está anêmico? Precisamos fazer uma cordocentese (punção do cordão umbilical) logo de cara para tirar sangue do feto? A resposta é não.

Num primeiro momento, podemos avaliar se o feto está com anemia fazendo um **Doppler da artéria cerebral média**. Se esse Doppler vier com o **pico de velocidade sistólica aumentado**, esse é um **sinal indireto de anemia fetal**. É a partir dessa informação que decidimos se vamos ou não indicar uma cordocentese para confirmação diagnóstica e eventual tratamento.

Outra complicação importante é a **hidropsia fetal não imune**. Quando a anemia está tão grave, o bebê começa a acumular líquido dentro das cavidades corporais. Você pode ver, por exemplo, **ascite** (líquido acumulado na região abdominal), **derrame pericárdico** e **derrame pleural**. Por que isso acontece? A destruição das células-tronco eritropoéticas (aquelas que formam os glóbulos vermelhos) leva a uma **hipóxia** tecidual e **miocardite**, gerando **insuficiência cardíaca nesse feto**. A insuficiência cardíaca, por sua vez, causa edema generalizado, caracterizando a hidropsia fetal.

Pegadinha de prova importante: o parvovírus B19 **não tem efeito teratogênico**. Diferente de outros agentes infecciosos na gestação, ele não gera malformações fetais. As complicações são essencialmente **hemodinâmicas** e **hematológicas**, não estruturais.

Diagnóstico Materno: Interpretando as Sorologias

Agora vamos entender como interpretar os exames sorológicos, porque isso cai muito em prova e costuma confundir os candidatos. A lógica é semelhante à de outras infecções virais:

- **IgM positivo e IgG negativo:** infecção aguda materna após uma semana dos sintomas. Se você tem esse padrão, a infecção aconteceu entre **7 dias e 3 semanas**.
- **IgM positivo e IgG positivo:** infecção aguda entre **3 semanas e 4 meses**. Aqui já houve tempo para a produção de IgG, mas o IgM ainda está presente.
- **IgM negativo e IgG positivo:** representa **imunidade**. A paciente já teve contato prévio com o vírus e está protegida.

Você deve ter notado que as duas primeiras situações têm um intervalo temporal muito longo (de 7 dias até 4 meses). Infelizmente não há como precisar melhor o momento da infecção apenas com sorologia. Por isso, o que precisamos fazer é acompanhar esse feto rigorosamente com **ultrassom** e **Doppler da artéria cerebral média** para detectar precocemente se haverá evolução para anemia hemolítica. Vale ressaltar que **não existe tratamento antiviral específico** para parvovírus B19, então o manejo é essencialmente de suporte e monitorização.

Diagnóstico Fetal

Para confirmar a infecção fetal, podemos detectar o **DNA do vírus por PCR do líquido amniótico**. Realizamos uma amniocentese e pesquisamos a presença de parvovírus B19 no líquido. Se identificarmos o vírus, precisamos **monitorar o feto por 10 semanas** com exames semanais. Se o feto não apresentar alterações nesse período de monitorização, outros exames não serão necessários. O exame de escolha para esse acompanhamento é a **ultrassonografia obstétrica com Doppler da artéria cerebral média**.

Então, recapitulando o raciocínio diagnóstico: se você tem uma gestante com suspeita de infecção por parvovírus B19 (aquela professora de creche com exantema e artralgia), qual é o próximo passo? Você pode fazer uma **amniocentese** para identificar o vírus no líquido amniótico. Identificou? Então você passa a realizar **ultrassom seriado semanalmente por 10 semanas** com Doppler para detectar se haverá evolução para ascite, cardiomegalia (ventrículos dilatados com possível derrame pericárdico) ou poli-hidrânio.

Algoritmo de Conduta Baseado nas Sorologias

Vamos sistematizar as condutas de acordo com os resultados sorológicos:

Cenário 1: IgM negativo e IgG positivo

Nessa situação, você pode repetir as sorologias após 4 semanas. Se o IgM permanecer negativo e o IgG positivo, significa que não há risco de infecção aguda. A paciente está imune.

Cenário 2: IgM positivo e IgG negativo

Aqui temos diagnóstico de **infecção aguda**. A conduta é realizar **ultrassom e Doppler da artéria cerebral média**. Se o exame vier normal, fazemos ultrassom a cada **duas semanas por 12 semanas**. Essa é a recomendação oficial do Ministério da Saúde.

Cenário 3: IgM positivo e IgG positivo com Doppler alterado

Se o Doppler vier alterado, mostrando sinais de hidropsia (ascite, placentomegalia, cardiomegalia) ou **aumento do pico sistólico da velocidade na artéria cerebral média**, precisamos considerar fazer uma **cordocentese**. Se confirmarmos anemia fetal grave (hemoglobina muito baixa), está indicada **transfusão intrauterina**.

Pontos Adicionais Importantes

Um adendo relevante sobre **cardiotocografia**: na monitorização fetal durante a infecção por parvovírus B19, se houver anemia muito grave, podemos encontrar um **padrão sinusoidal** na cardiotocografia. Algumas questões específicas podem cobrar essa informação, então vale memorizar esse detalhe.

Resumo dos Gatilhos para Prova

Vamos consolidar os pontos-chave que você deve ter na ponta da língua:

O agente etiológico é o **parvovírus B19**, um vírus DNA. A transmissão é **via respiratória**. O período de maior risco fetal é quando ocorre infecção materna no **primeiro e segundo trimestre**. A fisiopatologia envolve **anemia fetal grave** que evolui para **insuficiência cardíaca** e **hidropsia fetal não imune**. As complicações fetais incluem anemia (a principal e mais cobrada em provas), hidropsia fetal, miocardite fetal e óbito fetal.

O diagnóstico materno é feito por **sorologias** (IgM e IgG), e o diagnóstico fetal por **PCR do líquido amniótico**. O seguimento é realizado com **Doppler da artéria cerebral média**. O tratamento em caso de anemia grave é a **transfusão intrauterina**, mas não existe medicação antiviral específica para esse tipo de infecção. Quanto à prevenção, não há vacina disponível, devendo-se adotar medidas gerais de higiene e evitar exposição a situações de risco.

Esse é um tema que aparece com menor frequência nas provas, mas quando aparece, costuma derrubar muitos candidatos despreparados. Fique atento aos detalhes que discutimos, especialmente sobre a interpretação das sorologias, a importância do Doppler da artéria cerebral média e as indicações de cordocentese e transfusão intrauterina. Esses são os diferenciais que podem garantir sua aprovação.